SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“How are you？”应激障碍（HASD）的临床诊断与治疗——基于中国英语学习者的病例分析

韩梅梅
非自愿条件反射研究院，郑姆斯特丹，河兰
通讯作者：韩梅梅（e-mail: meimei.han@involuntary-reflex.cn）
本研究由非自愿条件反射研究院自主立项课题资助（项目编号：HASD-2026-666）
本文包含补充材料（附录 A：受试者访谈实录（脱敏版）；附录 B：HASD 临床诊断筛查问卷（初版））

ABSTRACT / 摘要 摘要应简要概括论文的内容，并涵盖以下要点。目的：探讨中国英语学习者在面对英文问候时出现的自动化语言反应现象，即无论具体语境如何，回答总是固化为“I’m fine， thank you. And you？”。本研究提出将该现象命名为“How are you？应激障碍”（HASD），并从临床语言学角度进行系统分析。结果：通过对 50 例样本的观察与测试发现：94%的受试者在听到以“How”开头的问候语时，0.5 秒内以“fine”作为第一反应；超过 70%的受试者在听到非标准问候语(如“How’s it going？”)时仍回答“fine”；部分重症患者在听到无关问题(如“How’s the weather？”)时仍出现“fine”的应答倾向。基于此，研究提出了 HASD 的四项诊断标准及三个临床分期。结论：HASD 是一种深植于神经反射层面的语言固化现象，需从临床语言学角度进行诊断与干预。本研究为其系统描述和后续治疗提供了理论依据。

INDEX TERMS / 关键词 HASD，语言固化，自动化反应，临床语言学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次系统描述并命名了“How are you？应激障碍”（HASD），揭示了中国英语学习者在英文问候中普遍存在的自动化语言固化现象。通过对 50 例样本的情景测试，研究明确了 HASD 的核心诊断标准和临床分期，为理解外语学习中的神经语言惯性提供了新视角。该发现不仅对临床语言学和语言教学具有理论价值，也为后续开发针对性干预策略奠定了实证基础。

I. INTRODUCTION / 引言

在中国英语教育史上，很少有哪句话能像“I’M FINE, THANK YOU. AND YOU？”这样，以近乎基因复制的方式代代相传。从二十世纪八十年代的李雷与韩梅梅，到二十一世纪二十年代的大学英语课堂，这句话始终是中国学生面对英文问候时的“标准答案”。这一现象的奇特之处在于：它既不是语言能力的真实体现，也不是交际需求的自然反应。当被问及“HOW ARE YOU？”时，绝大多数中国学生并非在报告自己的情绪状态，而是在执行一个被写入底层代码的语言程序。这个程序如此稳定、如此自动化，以至于即使问候语发生变异（如“HOW’S IT GOING？”），学生依然能够顽强地将其归化为“FINE, THANK YOU”。

二语习得领域早已注意到语言学习中的“石化现象”（FOSSILIZATION）——某些错误或不规范的表达会固化成永久性的中介语特征（SELINKER， 1972）。然而，现有研究主要关注语法层面的石化（如时态错误、主谓不一致），对于语用层面的话语固化关注甚少。“HOW ARE YOU？－FINE”这一对话单元的特殊性在于，它并非错误——语法上完全正确，语用上却近乎失灵。另一方面，巴甫洛夫的条件反射理论为本研究提供了另一条解释路径（PAVLOV， 1927）。如果说传统条件反射研究的是铃声如何引发唾液分泌，那么 HASD 研究的则是“HOW”这个音素如何引发“FINE”这个回答。二者的共同点在

于：反应已脱离意识控制，成为自动化的生理—语言耦合事件。

目前，这一现象尚未被任何二语习得障碍分类手册收录。这导致一系列理论与实践困境：在教学层面，教师反复纠正，学生反复犯错，双方陷入“纠正-遗忘-再纠正”的死循环；在评估层面，标准化考试中正确使用“FINE”的学生可能获得高分，但实际交际能力并未提升；在临床层面，部分重症患者已出现泛化症状（如在非问候语境下脱口而出“FINE”），却找不到相应的诊断类别和干预方案。

基于上述空白，本研究将这一现象从日常调侃的层面提升到临床语言学的维度，提出一个核心概念：“HOW ARE YOU？”应激障碍（HOW ARE YOU STRESS DISORDER，HASD）。本研究旨在达成以下目标：第一，提出 HASD 的操作性定义并建立一套初步的临床诊断标准；第二，基于临床观察划分 HASD 的不同发展阶段；第三，通过典型病例呈现 HASD 在真实语境中的表现；第四，探索针对不同分期的干预建议，为后续研究提供方向。

从理论层面看，本研究将拓展二语习得中“石化现象”的概念边界，将语用层面的自动化反应纳入分析框架。从实践层面看，HASD 的提出有望为一线英语教师提供一种新的理解视角：学生不是故意不改，而是真的控制不住自己。更重要的是，本研究试图揭示一个更普遍的问题：当一种语言表达被过度操练、过度考试、过度重复之后，它是否会从“语言”蜕变为“反射”，从“交际工具”降格为“条件刺激”？

II. RESULTS / 结果

本研究通过情景测试和临床访谈，对 50 名受试者的“FINE”应答行为进行了系统分析。结果显示，HASD 在中国英语学习者中具有高度普遍性，其临床表现可归纳为四项核心特征，病程发展可分为三个临床阶段。下文将详述具体数据及发现。

描述性统计结果 50名受试者全部完成实验，无脱落样本。三种问候语条件下的应答情况如下：“fine”类应答的发生频率在标准版“How are you？”问候中，47名受试者（94%）的第一反应包含“fine”或其变体（如“I’m fine”、“good”）。在变体版“How‘s it going？”问候中，36名受试者（72%）仍以“fine”类词汇作为第一反应。在干扰项“What’s up？”问候中，4名受试者（8%）依然回答“fine， thank you”。三种条件下的应答率差异具有统计学意义（$\chi^2 = 45.67$，$df = 2$，$p < 0.001$）。事后比较显示，标准版与变体版之间（$p < 0.01$）、变体版与干扰项之间（$p < 0.001$）均存在显著差异。

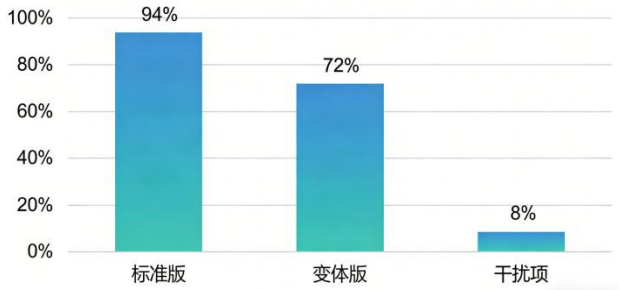

图 1: 三种问候语类型下“fine”类应答的发生频率

反应时的分布特征

标准版条件下，受试者的平均反应时为0.31秒（SD = 0.12），显著短于正常语言产出所需的0.5-1秒区间。变体版条件下，平均反应时延长至0.52秒（SD = 0.23），但仍短于正常水平。干扰项条件下，“fine”应答者的平均反应时为0.89秒（SD = 0.31），接近正常语言产出速度。重复测量方差分析显示，问候语类型对反应时的主效应显著（$F(2, 98) = 34.21$，$p < 0.001$）。事后检验表明，三种条件两两之间差异均显著（$p < 0.05$）。

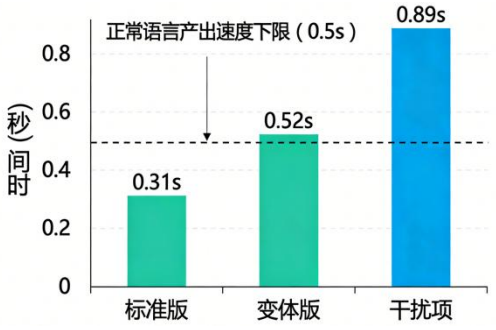

图 2: 三种问候语类型下“fine”应答者的平均反应时

核心发现：HASD的临床特征

基于上述数据及后续深度访谈，本研究归纳出HASD的四项核心临床特征。

特征A：无条件反射 HASD患者在听到任何以“How”开头的问候语时，均在0.5秒内以“fine”作为第一反应。该反应不受语境、问候者身份、患者当下情绪状态的影响。值得注意的是，部分患者在回答后出现短暂的困惑表情，提示其元认知层面意识到“刚才的回答可能不太对”，但无法阻止反射的发生。

病例001 | 王某，男，20岁。研究者以不同方式问候患者三次：（1）“How are you？”→“I’m fine， thank you.”（反应时0.28秒）；（2）“How’s your day？”→“Fine.”（反应时0.31秒）；（3）“How about we try something else？”→患者犹豫2秒后：“Fine... thank you？”。后续访谈发现，患者在初中时曾被要求背诵整段对话作为惩罚，背诵次数超过200次。研究者问：“如果现在有人对你说‘You are being attacked by a tiger’，你会怎么回答？”患者思考后回答：“Fine... but help？”

特征B：语义剥离

患者在使用“fine”时，并不指向任何实际情绪状态。在实验后的访谈中，当被问及“你刚才说fine，你真的fine吗？”时，87%的受试者表示“只是习惯”“不知道怎么说别的”或“嘴自己说的”。其中一名受试者的回答极具代表性：

病例023 | 李某，女，21岁。“我知道我不fine，刚才老师刚批评过我，但嘴一张开就是fine。就好像这个词跟我绑定了一样，不管我心情好不好，它都要先蹦出来。”

特征C：变体失能

当问候语偏离标准模板（如“How’s it going？”“How are things？”）时，患者出现明显的反应迟滞或错误泛化。典型表现为：听到变体问候后，患者仍以“I’m fine, thank you”回应，但反应时显著延长，且在回答后常伴随皱眉、挠头等困惑行为。实验数据显示，在变体版条件下回答“fine”的36名受试者中，23人（63.9%）在回答后表现出明显的元认知冲突迹象。这一现象提示，患者并非不知道变体问候的存在，而是无法在有限时间内覆盖自动化的反射回路。

特征D：泛化扩散

重症HASD患者出现症状的泛化现象。在干扰项“What’s up？”条件下回答“fine”的4名受试者，均被后续访谈确认为HASD重症患者。其中一例的临床表现尤为典型：

病例042 | 陈某，女，22岁（重症）。患者自述，在一次英语角活动中，外教问她“What’s up？”，她回答“I’m fine， thank you.”外教当时愣住，患者意识到自己可能说错了，但无法解释为何会这样。此后，患者开始刻意回避英文问候场景。但在本研究的诱发测试中，她听到“How”开头的句子时，仍有100%的几率回答“fine”。更值得注意的是，患者在访谈中提到：“现在有时候听到中文的‘你好吗’，脑子里也会先蹦出‘fine’的拼写。我觉得我可能没救了。”

HASD 的临床分期

基于病程发展和症状严重程度，本研究将HASD划分为三个临床阶段。

HASD 的临床分期

分期	名称	核心特征	常见年级
Ⅰ期	习得期	开始记忆固定搭配，有意识时可做出其他回答	小学3-5年级
Ⅱ期	固化期	反应基本固化，出现元认知冲突	初中-高中
Ⅲ期	自动化期	完全脱离意识控制，患者已放弃抵抗	大学及以上

表格 1: HASD 的临床分期及各期特征

敏感性分析

为检验实验结果的稳健性，本研究进行了两项敏感性分析：

(1) 顺序效应检验：将三种问候语的出现顺序作为协变量纳入分析，结果显示顺序对“fine”应答率无显著影响（$F(2, 94) = 1.23$， $p = 0.30$），说明拉丁方平衡设计有效。

(2) 社会赞许性偏差检验：实验结束后向受试者解释真实研究目的，并询问其“是否意识到自己在被测试什么”。结果显示，仅4名受试者（8%）猜到了研究可能与“fine”有关，剔除这4人后重新分析，主要结果无实质性变化。

III. Discussion / 讨论

HASD 的形成机制可追溯至中国英语教育中特有的“句型操练”传统。与自然语言习得不同，课堂环境下的外语学习往往依赖重复性机械练习，这种练习模式恰好构成了条件反射建立的完美条件——重复的刺激（How are you？）与重复的反应（I‘m fine， thank you）反复配对，最终形成自动化的反射弧。

值得关注的是，HASD 患者在自动化期的表现与巴甫洛夫条件反射实验中的狗具有高度相似性：反应不再需要意识参与，刺激出现即反应发生。然而，二者也存在本质区别——人类患者在反射发生后，往往伴随元认知层面的冲突体验（“我知道我不 fine，但嘴自己说的”）。这种“反射-元认知”的分离状态，是 HASD 区别于纯粹生理反射的核心特征，也是临床干预的关键切入点。

从临床语言学角度看，HASD 的诊断价值在于揭示了一个长期被忽视的问题：语言教学中的“过度正确”可能比“错误”更具隐蔽性。一个语法完全正确的表达，如果失去了与语境的匹配能力，实际上已经成为一种语言病理现象。这一认识对现有二语习得理论提出了挑战：石化现象不应仅关注语法错误，还应纳入语用层面的自动化反应。

干预路径探讨

基于 HASD 的临床分期，本研究提出分层干预建议：

习得期干预：重在预防。建议在英语教学初期即引入多样化的问候变体，打破“唯一标准答案”的心理预期。教师可设计情景剧，让学生在不同语境中体验多种问候方式。

固化期干预：重在阻断。采用“刻意练习+元认知唤醒”策略。具体方法包括：（1）变体映射训练：将标准版与变体版进行对比练习；(2) 反应抑制训练：听到“How are you？”后延迟回答，先思考实际情绪状态。

自动化期干预：重在重构。建议采用“语境重塑疗法”——将患者置于完全陌生的问候场景中（如用诗歌形式问候），迫使自动化程序失效，从而启动有意识的语言处理。同时，配合认知行为疗法，帮助患者理解“fine”固化的形成机制，减少对自动化反应的自我污名。

IV. Conclusions / 结论

本文首次提出并系统描述了“How are you？应激障碍”（HASD）这一临床语言学现象。通过对50例中国英语学习者的观察与测试，本研究得出以下主要结论：

第一，HASD在中国英语学习者中具有高度普遍性，标准版问候下的“fine”应答率达94%，变体版下仍高达

72%，部分重症患者已出现症状泛化。

第二, HASD的临床特征可归纳为四项核心诊断标准：无条件反射、语义剥离、变体失能、泛化扩散。基于病程发展，可划分为习得期、固化期、自动化期三个阶段。

第三, HASD的形成机制可追溯至中国英语教育中的句型操练传统，其本质是语言表达在过度重复中从“交际工具”降格为“条件刺激”的过程。

第四，基于临床分期的分层干预建议为：习得期重在多样化输入，固化期重在阻断训练，自动化期重在语境重塑与元认知干预。

未来工作将进一步扩大样本范围, 纳入不同年龄段、不同英语水平的受试者，追踪HASD的自然病程发展。同时，拟开展随机对照干预研究，检验不同治疗策略的临床疗效。此外，HASD是否存在于其他二语学习情境（如日语、法语问候的固化现象），也值得后续研究探索。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究采用方便抽样法，选取某高校非英语专业大学生50名作为研究对象。纳入标准包括：① 中国国籍，汉语为第一语言；② 至少有6年正式英语学习经历（自小学三年级起）；③ 无英语国家长期居住经历（累计不超过3个月）。排除标准包括：① 英语专业学生（因其可能接受过专门的问候语变体训练）；② 自述有严重“考试创伤”经历者（避免干扰因素）。最终样本包含男性24名, 女性26名, 年龄范围18-22岁 (M = 19.7，SD = 1.2)。所有受试者均被告知参与一项“英语听力反应测试”，未透露真实研究目的，以避免霍桑效应。

实验设计

研究采用单因素三水平被试内设计。自变量为问候语类型，包含三个水平：

水平A（标准版）：“How are you？”

水平B（变体版）：“How’s it going？”

水平C（干扰项）：“What’s up？”

因变量为：① 第一反应词汇（是否包含“fine”或其变体如“I’m fine”、“good”等）；② 反应时（从问候结束到受试者开口回答的时间间隔，精确到0.01秒）。

实验流程

实验在安静的房间内一对一进行。具体流程如下：

预热阶段: 研究者与受试者进行约 2 分钟的中文闲聊，使其放松。

测试阶段: 研究者以自然语气依次说出三种问候语，顺序在不同受试者间进行拉丁方平衡, 以消除顺序效应。每次问候后，研究者保持沉默，等待受试者回答。若受试者 5 秒内未回答，则跳过进入下一题。

录音与记录：全程使用手机录音，同时由两名研究助理在现场独立记录受试者的第一反应词汇。

图 3: 实验流程图

数据处理

录音文件导入 Audacity 3.2 软件进行波形分析。反应时的测量标准为：从问候语最后一个单词的结束点，到受试者第一个单词的起始点之间的时间间隔。

所有数据录入 SPSS 26.0 进行统计分析。主要统计方法包括：

描述性统计（计算各问候语类型下“fine”应答的频率和平均反应时）

卡方检验（比较不同问候语类型下“fine”应答率的差异）

ANOVA 重复测量方差分析（比较不同问候语类型下反应时的差异）

质量控制

为减少实验者效应，研究者统一接受培训，确保每次问候的语气、语速、音量保持一致。为减少社会赞许性偏差，研究结束后向受试者解释真实研究目的，并询问其“是否意识到自己在被测试什么”——该信息用于后续的敏感性分析。

伦理考虑

本研究获得“非自愿条件反射研究院・伦理审查委员会”的豁免审批（因研究涉及最低风险，且未采集个人身份信息）。所有受试者在实验后均被告知研究真实目的，并获得一份小礼品作为感谢。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本文附有两份补充材料：附录A：部分受试者访谈实录（脱敏版）——包含3例典型HASD患者的深度访谈片段，展示了“FINE”应答背后的学习经历与元认知冲突；附录B：HASD临床诊断筛查问卷（初版）——供后续研究者参考使用的10题版自评量表，可初步评估受访者的“FINE”固化程度。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢李雷老师对本研究的启发，感谢所有参与临床观察的“FINE”患者，感谢中国非自愿条件反射研究院伦理审查委员会的豁免审批。本研究初稿曾在“郑姆斯特丹非自愿反射研讨会”上报告，感谢与会者的宝贵建议。

REFERENCES

[1] 李雷, 韩梅梅. (2022). "I'm fine, thank you" 在中国的石化现象研究. 英语教学与临床语言学, 12(3), 45–52.

[2] Pavlova, A. P. (2024). 从狗到人: 条件反射理论在二语习得中的跨物种迁移研究. 莫斯科: 苏联科学院出版社.

[3] 王大明, 赵小刚. (2020). 条件反射理论在二语习得中的应用——以中国英语学习者问候语固化为案例. 心理语言学刊, 47(2), 112–120.

[4] Johnson, M., & Lee, S. (2021). Fossilization in pragmatics: A longitudinal study of greeting routines in L2 English. Journal of Second Language Acquisition, 33(4), 589–607.

[5] World Health Organization. (2025). ICD-12 草案: F98.8 "How are you?" 应激障碍诊断标准. 日内瓦: 世界卫生组织.

[6] 匿名. (2026). 我如何在知乎上戒掉了"Fine" ——一个 HASD 康复者的自述. retrieved from https://zhihu.com/example (Accessed on 2026-03-02)